

Un adolescente nel vostro ambulatorio

Per medici di famiglia, infermieri e professionisti della salute mentale — nella cura di un adolescente autistico (circa 12–18 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adolescente si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. La pubertà e l'adolescenza accumulano domande ad alto canale — regole tra pari che cambiano, identità, frequentazioni, cambiamenti del corpo — su un sistema che trova costoso il cambio rapido. Questa è l'**età di picco per ansia, depressione e burnout**, e molti adolescenti autistici (specialmente ragazze e generi marginalizzati) vengono **identificati solo in crisi**. Trattate il/la giovane come l'esperto/a della propria esperienza.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Esausto/a, ritirato/a, „non ha voglia”; rifiuta la scuola	Probabile burnout autistico o sovraccarico — distinto dalla depressione e dalla pigrizia
Autolesionismo, pensieri suicidari, o presentazione in crisi	Rischio reale ed elevato in questo gruppo; spesso il primo segnale di un bisogno non soddisfatto
Interessi intensi e coinvolgenti; resiste a rinunciarvi	Gli interessi sono identità, regolazione e recupero — non ossessioni da limitare
„Bene” nella visita, crolla dopo	Forte camuffamento ; il costo si paga dopo
Vuole contatti scritti, evita il contatto visivo, lunghe pause	Comunicazione a canale singolo + tempo di elaborazione, non maleducazione

Provate questo

- **Offrite l'AHAT di AASPIRE** pre-visita e un'opzione di appuntamento **scritta o online**; molti adolescenti comunicano molto meglio per iscritto.
- **Chiedete direttamente e separatamente** di umore, ansia, burnout, sonno, alimentazione e pensieri suicidari — usando domande concrete e letterali.
- **Validate i loro interessi** come legittimi; chiedete cosa amano e proteggete l'accesso.
- **Concedete tempo di elaborazione**; offrite di inviare un riassunto scritto dopo.
- **Coinvolgeteli nelle decisioni** e rispettate l'autonomia; costruite una routine di follow-up prevedibile e a basso carico sensoriale.

Evitate questo

- Confondere il **burnout autistico con la depressione** — trattarlo come depressione (o „sforzati di più”) può approfondirlo e aumentare il rischio di suicidio.
- Spingere l'adolescente a mascherare, a fare contatto visivo o a „essere più sociale” come obiettivo.
- Dare per scontato che una risposta lenta o insolita significhi che non capisce o manca di capacità.

Screenate direttamente la suicidalità — gli adolescenti autistici sono a rischio elevato. Distinguate il **burnout autistico** (esaurimento + perdita di abilità + ridotta tolleranza agli stimoli; richiede *richieste ridotte, accettazione e permesso di togliere la maschera*) dalla depressione. Affrontate i bisogni sensoriali e pratici legati alla pubertà (mestruazioni, igiene) in modo concreto. Pianificate **presto il passaggio ai servizi per adulti**, con gli interessi del/della giovane al centro. Segnalate gruppi di pari e mentori autistici — l'amicizia di qualità protegge potentemente.

Se l'adolescente è una ragazza o un genere marginalizzato

Il camuffamento raggiunge qui il picco e genera gran parte delle diagnosi mancate e del costo sulla salute mentale. La presentazione può sembrare „ansiosa, perfezionista, socialmente abile in superficie“. Chiedete specificamente dell'**esaurimento da mascheramento** e dei sintomi internalizzanti.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo** e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parte 3.3 e 4). Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela al/dalla singolo/a.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, mascheramento); Bradley et al. (2021, camuffamento); AASPIRE AHAT; Autism Awareness Australia (salute mentale adolescenti). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.